

권 고 사 항

1. 제 목 : 병원내 감염예방 및 감염병 신고에 관한 사항
2. 관계기관 : ★★보훈병원, BBBB실
3. 내 용 : 정부에서는 감염병 전문병원 설립과 역학조사관 확충 등 방역체계 강화를 국정과제로 선정하여 감염관리를 강화하고 있으며, 공단에서는 정부의 국정과제 수행과 보훈병원의 감염발생을 사전에 예방하기 위하여 [표 1]과 같이 정원을 증원하였습니다.

[표 1] 감염병 관리 강화 관련 정원 증원('17.11.28.) 현황

구 분	계	◇◇병원	★★병원	♣♣병원	♠♠병원	♠♠병원	비고
의사직	8	3	1	1	1	2	
간호직	10	4	2	2	2	-	
계	18	7	3	3	3	2	

가. ★★보훈병원 감염예방 활동에 관한 사항

★★보훈병원에서는 병원내 감염예방을 위하여 자체적으로 감염관리 순회 점검표에 의한 실태조사를 '18.6월부터 매주로 실시하고 있습니다.

'15년도 메르스 사태이후 감염 예방에 대한 중요성이 커지고 있으며, 보훈병원에 재원중인 환자는 대부분이 고령이고 각종 만성질환을 앓고 있어 면역력이 떨어져 감염에 취약하기 때문에 감염예방 활동을 생활화하여 병원내 감염이 발생하지 않도록 노력하여야 합니다.

또한, 보훈병원은 보건복지부에서 시행하고 있는 의료기관인증제 평가를 주기적으로 받고 있으며, 손 위생, 위험물질관리, 세탁물관리, 부서별 감염활동 등에 대해서는 의료기관인증제 평가 시 평가항목으로 구성되어 있으므로 감염관리를 철저히 하여야 합니다.

따라서, ★★보훈병원에서는 의료기관인증제 평가 및 병원내 감염관리 강화를 위하여 감염예방 실태를 수시로 점검하고 교육하는 등 감염예방 활동을 강화하여 병원내 감염이 발생하지 않도록 노력하여야 합니다.

그런데, ★★보훈병원 감염예방 활동을 확인한 결과, 병동, 외래, 검사실 등 환자 접점부서에 대한 손위생 수행률 모니터링 결과를 보면, 2018년 병원 손위생 수행률 목표를 91%로 하고 있으나 [표 2]와 같이 2분기까지 79.4%로 미달하고 있으며 '17년도 보다 4.5% 하락 하는 등 손위생이 적절하게 이루어지지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표 2] 손위생 수행률 현황

구분	관찰건수	손위생 수행건수	손위생 수행률	증 감 (전년도 기준)
2016년	2,096	1,715	81.8	-
2017년	2,234	1,874	83.9	2.1
2018년 2분기	1,274	1,012	79.4	△4.5

또한, ★★보훈병원에서는 병원내 감염예방을 위하여 자체적으로 실시하고 있는 감염관리 순회 점검 결과를 보면, 병동, 외래부서 등에서 사용하고 있는 알콜젤, Y-Tube, 응급 멸균물품(suction cath, ambu bag 등)의 유효기간이 지난채 물품을 보관하고 있는 사례가 지속적으로 발생하고 있으며, 유효기간을 기재하지 않고 물품(락스, 환경소독제, 알콜솜 등)을 사용하고 있는 사례가 발생하는 등 감염관리가 적절하게 이루어지지 않고 있는 사실이 있습니다.

나. 감염병 신고에 관한 사항

보훈병원에서는 내원한 환자 중 전문의가 감염병환자로 진단한 환자들에 대해서는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 관할 보건소에 신고하고 있으며, 보훈병원별 감염병 환자 신고실적은 [표 3]과 같습니다.

[표 3] 보훈병원별 감염병 환자 신고현황

구분	계	◇◇병원	★★병원	♣♣병원	♠♠병원	♣♣병원	비 고
2016년	438	164	37	131	36	70	
2017년	506	187	83	148	44	44	
2018.6.30.	274	109	29	75	35	26	
계	1,218	460	149	354	115	140	

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조에 따르면, 감염병을 제1군 ~ 제5군, 지정감염병, 세계보건보건기구 감시대상 감염병, 생물테러감염병, 성매개 감염병, 인수(仁獸)공통감염병 및 의료관련감염병으로 구분하고 있으며, 동 법률 제11조에서는 의사나 한의사가 감염병환자 등을 진단하거나 사체를 검안한 경우 감염병환자 등이 제1군 감염병부터 제4군 감염병까지에 해당하는 감염병으로 사망한 경우 감염병 병원체 확인 기관의 소속 직원은 실험실 검사 등을 통하여 감염병 환자 등을 발견한 경우 그 사실을 감염병 병원체 확인기관의 장에게 보고하도록 되어 있습니다.

또한, 보고를 받은 의료기관의 장은 제1군 감염병부터 제4군 감염병까지의 경우에는 지체 없이, 제5군 감염병 및 지정감염병의 경우에는 7일 이내에 보건 복지부장관 또는 관할 보건소장에게 신고하여야 합니다.

더불어, 보훈병원 신고 절차는 의사가 감염병 대상 질환을 검진하면 EMR에 감염병 발생보고서가 자동으로 생성되어 이를 작성하면 감염전담 간호사가 보훈 병원별 관할 보건소장 등에게 신고하고 있습니다.

따라서, 집단 감염예방·관리 및 법정전염병 신고·관리 등의 업무를 담당 하는 직원은 의사나 한의사가 감염병환자 등을 진단하였을 경우에는 EMR에 자동 생성된 감염병 발생보고서를 적기에 작성하여 관할 보건소 등에 보고하여야 하며, 감염병 신고가 지연되거나 누락되는 일이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하여야 합니다.

그런데, 2016. 1. 1. ~ 2018. 6.30.까지 보훈병원 감염병 신고현황을 확인한 결과 [표 4]와 같이 보훈병원에서는 감염병 발생을 지연하여 신고한 사실이 있습니다.

[표 4] 보훈병원별 감염병 지연 신고현황

구분	환자명	분 류	감염상명병	치료시작일	신고서작성일 (EMR)	신고일자	비고
◇◇병원	안**	제3군	결핵	16.02.05	16.02.10	16.02.10	
◇◇병원	김**	제3군	결핵	16.02.25	16.02.19	16.02.22	
◇◇병원	장**	제3군	결핵	16.03.19	16.03.19	16.03.21	
◇◇병원	고**	제2군	수두	16.05.20	16.05.20	16.05.23	
◇◇병원	고**	제3군	결핵	16.06.24	16.06.27	16.06.27	
◇◇병원	김**	제3군	결핵	16.07.12	16.07.03	16.07.14	
◇◇병원	김*	제3군	결핵	16.10.08	16.10.10	16.10.10	
◇◇병원	이**	제3군	결핵	16.10.28	16.10.31	16.10.31	
◇◇병원	홍**	제3군	결핵	16.11.22	16.11.17	16.11.21	
★★병원	이**	제3군	결핵	16.01.29	16.01.29	16.02.01	
★★병원	김**	제3군	결핵	16.03.15	16.03.18	16.03.18	
★★병원	이**	제3군	결핵	16.06.17	16.06.17	16.06.19	
♠♠병원	정**	제3군	쯔쯔가무시증	16.05.06	16.05.13	16.05.13	
♠♠병원	김**	제3군	결핵	16.05.27	16.05.27	16.05.30	
♠♠병원	방**	제3군	쯔쯔가무시증	16.09.14	16.09.19	16.09.19	
★★병원	김**	제3군	결핵	17.04.27	17.05.02	17.05.02	
♠♠병원	최**	제3군	쯔쯔가무시증	17.07.26	17.07.31	17.07.31	
♠♠병원	김**	제3군	결핵	17.08.07	17.08.14	17.08.14	
♠♠병원	김**	제3군	쯔쯔가무시증	17.10.30	17.11.01	17.11.01	
♣♣병원	민**	제3군	쯔쯔가무시증	18.02.02	18.02.05	18.02.05	
♠♠병원	권**	제3군	결핵	18.05.15	18.05.18	18.05.18	

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- “가”항과 관련하여, 진료재료 등의 유효기한 관리 및 손 위생 수행률 목표 달성 등을 위하여 감염예방 실태를 수시로 점검하고 교육하는 등 감염예방 활동을 강화하시기 바랍니다.(통보)

○ 사업이사는

- “나”항과 관련하여, 감염병환자 등을 진단하였을 경우에는 감염병 발생보고서를 적기에 작성하여 관할 보건소 등에 보고하는 등 감염병 신고가 지연되는 일이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(권고)